EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 95484
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-10-23 12:04:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: SEBASTIAN SEGUNDO MENDOZA VASQUEZ			RUN	: 5.725.758-K
F.Nac	: 02-12-1946	Edad	: 77 AÑOS, 10 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: LLAHUIMAVIDA ORIENTE			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 89029740		
Fecha Ingreso	: 2024-10-19	Fecha Egreso	: 2024-10-23 12:04:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J84.1-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Fibrosis Pulmonar progresiva. Bronquiectasias sobreinfectadas? --- Usuario de o2 domiciliario
2. TEP cronico
3. Cardiopatia isquemica cronica ---- IAM marzo 2024 (PTCA ADA)
4. Ca de Vejiga T1N0M0

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J84.1-OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES INTERSTICIALES CON FIBROSIS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. C67-TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente masculino quien acude al servicio de urgencia por exacerbación de disnea basal y aumento de los requerimientos de O2
Ingresos 2024 1) IAM con PTCA ADA marzo; 2) TEP trombolizado julio 2024
Ingresa GAS PAFI 174 control hoy 203
ANGIOTAC de tórax: TEP crónico Signos de HTP y sobrecarga de cavidades der. calcificaciones de plano valvular aortico. Ateromatosis coronaria y aortica. Enf pulmonar difusa fibrotica patron UIP
Parámetros inflamatorios bajos. Panel viral negativo.
En sala se recibe en condiciones clínicas regulares con O2 por MV a 35% , disneico con UMA.
Evolucionado favorablemente logrando bajar el requerimiento de oxígeno a su basal (naricera 2 litros) sin quiebre clínico.
Examen físico Cardiopulmonar: MP+ disminuido globalmente, con crepitantes finos bilaterales, RsCsRs NAS
Abdomen: blando, depresible, no doloroso. Extremidades. simétricas sin edema ni signos de TV
En condiciones clínicas para continuar continuar tto con HODOM

PLAN DE MANEJO:

HODOM
Completar tto ATB
kine Respiratoria
Control sos

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen: liviano hiposodico
3. fio2 para sato2 > 88% (Titular O2)

4. Ceftriaxona 2 gr EV dia (4 /10)
5. Prednisona 20 mg dia por 5 dias vo
6. B. ipratropio 4 puff cada 4 hrs
7. Pirfenidona 3 comp dia
8. Pregabalina 75mgrs vo dia
9. Dabigatran 110 mgr vo cada 12hrs
10. Losartan 50mgr vo cada 12hrs
11. Hidroclorotiazida 50 mg cada 12 vo
12. kine respiratoria
13. Continuar con tto crónico en domicilio

EXÁMENES Y RESULTADOS

Glicemia : 80 | Albumina : 3,3 | Creatinina : 0,80 | Calcio : 9,3 |Clearence Calculado(MDRD) : 93,74 | Lactato : 0,9| Proteina C Reactiva : 8,7 | Uremia : 45 | Sodio (Na) : 139,00 mmol/L | Potasio (K) : 3,30 | Cloro (Cl) : 97,00 | leucocitos : 7,10 | Recuento Hematies : 5,86 Mill/ul | Hematocrito : 51,6 * o/o | Hemoglobina : 17,0 * | Plaquetas : 155 | Segmentados : 73 o/o | Linfocitos : 14 * o/o | Monocitos : 10 | V.H.S. : 8 | Procalcitonina : 0,03

CARABALLO DE HURTADO
JENNIFER DEL CARMEN
MEDICO TRATANTE
26251544-3

JEFE SERVICIO